

Mononucleosis Infecciosa (La Enfermedad del Beso)

Enfermedad linfoproliferativa aguda.

Pilar Clínico

Faringitis,
Fiebre,
Linfadenopatía.

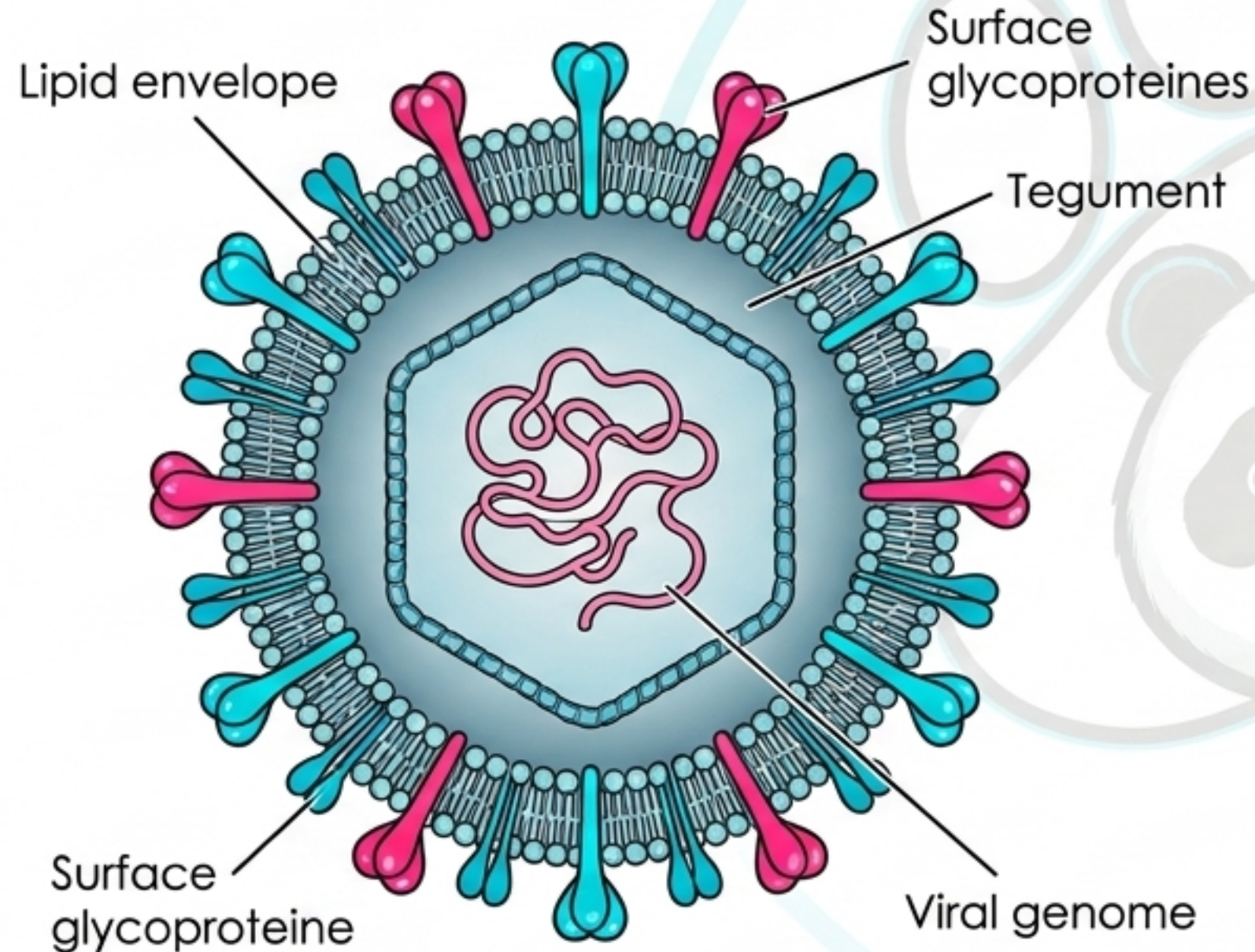
Pilar Serológico

Aparición de
anticuerpos
heterófilos.

Pilar Hematológico

Leucocitosis
mononuclear
con linfocitos
atípicos.

Etiología: El Virus de Epstein-Barr (VEB)



- **Clasificación:** Herpes virus tipo 4 (Familia Herpesviridae).
- **Tropismo:** Virus linfotrófico (Infecta y se replica en células epiteliales y linfocitos B).
- **Prevalencia:** 95% de adultos son portadores asintomáticos.

Riesgo Oncológico: Implicado en tumores como el Linfoma de Burkitt, Carcinoma nasofaríngeo, Enfermedad de Hodgkin, y Linfoma de células B en inmunodeprimidos.

Epidemiología y Vector de Transmisión



- **Reservorio:** Exclusivamente humano.
- **Vía:** Salival (contacto directo).
- **Condición:** Virus con envoltura frágil; requiere exposición a virus fresco en líquidos corporales.

Niños Pequeños

Frecuentemente presentan signos atípicos (rash, neutropenia, neumonía).
Anticuerpos heterófilos negativos en ~50% de los casos.

Adolescencia / Adultez Temprana

Mayoría de casos sintomáticos clásicos.
Aumento progresivo en la positividad serológica.

Periodo de Incubación: 3 a 7 semanas
(prolongable hasta 30-50 días).

Fase Sintomática: 2 a 4 semanas.

Patogénesis FASE 1: Infección y Transformación

1. Entrada y Replicación

Infección directa del epitelio orofaríngeo y de las glándulas salivales.



2. Tropismo Linfocitario

Infección de los **Linfocitos B** (mediante el receptor CD21 en células epiteliales y linfocitos B) provocando **diseminación sanguínea**.

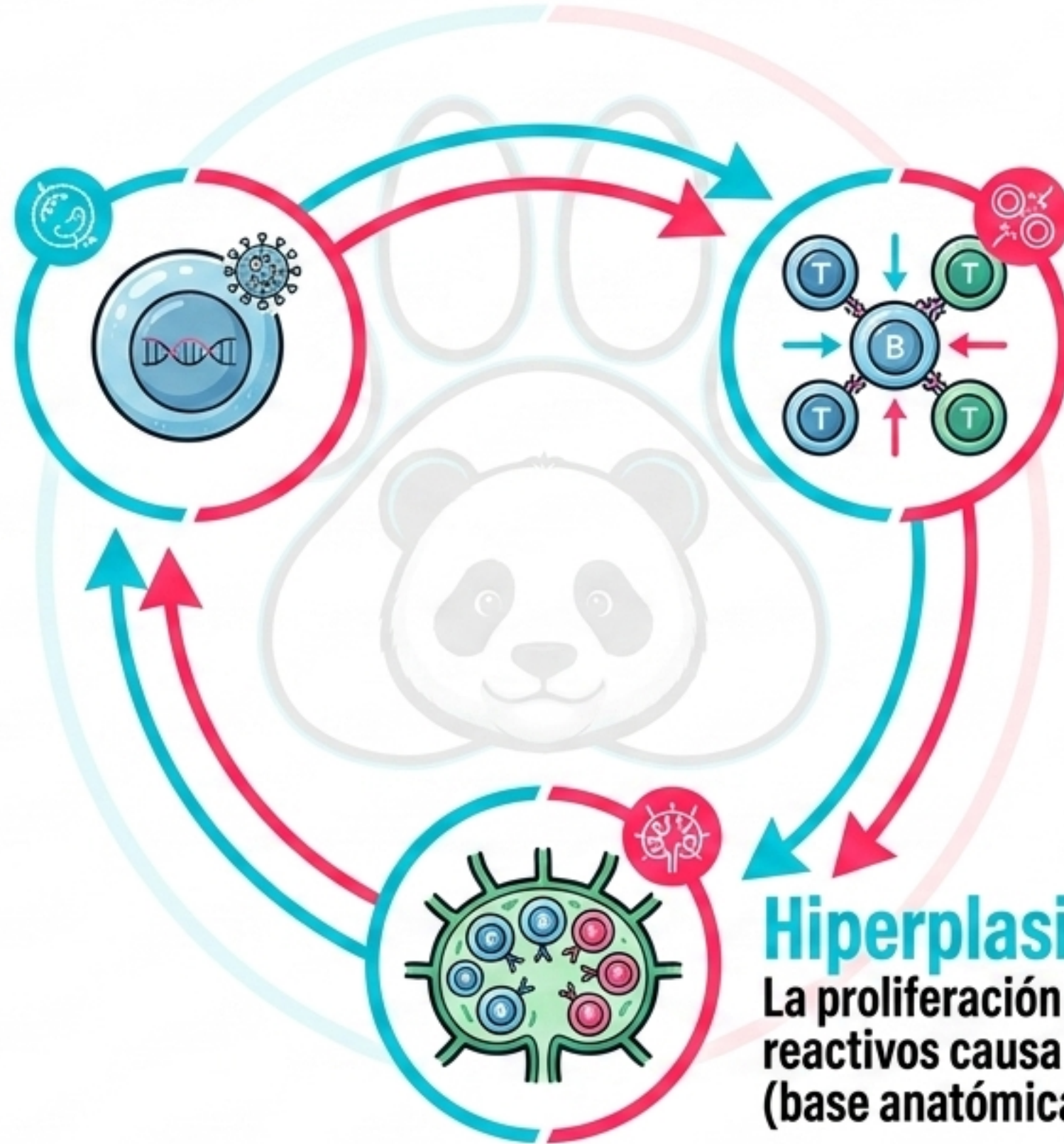


3. Transformación Celular

Los Linfocitos B infectados se transforman en **células plasmáticas**, las cuales comienzan a **secretar anticuerpos heterófilos**.

Patogénesis FASE 2: Respuesta Inmune y Latencia

Latencia
Reservorio vitalicio del virus
= Linfocitos B de memoria.



Inducción

Los Linfocitos B infectados inducen una respuesta masiva de Linfocitos T reactivos.

Hiperplasia

La proliferación de Linfocitos B + Linfocitos T reactivos causa la hiperplasia del tejido linfático (base anatómica de la linfadenopatía clínica).

Manifestaciones Clínicas: La Tríada Clásica (MI Anginosa)

Fiebre



Elevación abrupta de la temperatura.

Faringoamigdalitis



Forma exudativa con marcado edema faríngeo.

Linfadenopatía



Inflamación severa de ganglios linfáticos, típicamente cervicales.

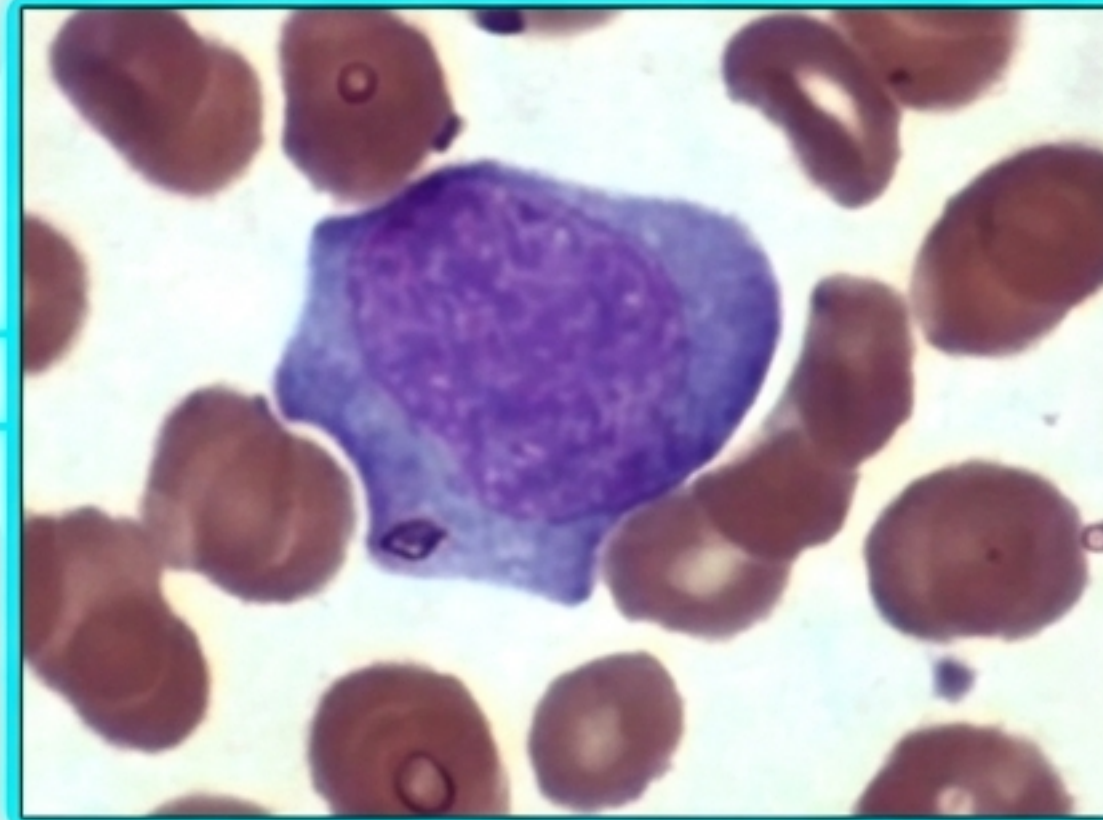
Alteraciones Analíticas: Perfil de Laboratorio

Hematológico

Leucocitosis (10,000 - 20,000/mm³).
Predominio de Linfocitos.

Célula Clave

>10% de linfocitos
ATÍPICOS o Células de
Downey (T CD8+).



Inmunológico

Inversión cociente
CD4+/CD8+ (aumento de
CD8 reactivos frente a
antígenos virales).

Hepático y Plaquetario

Trombocitopenia.
Elevación de enzimas
hepáticas (GGT, GOT, LDH
y fosfatasa alcalina).

Diagnóstico Primario: Pruebas Rápidas

Pilar Principal:

La sospecha por la **CLÍNICA** es fundamental.

Prueba Paul-Bunnell:

Detección de anticuerpos heterófilos.
Prueba más sensible y específica.
Anticuerpos tipo IgM = infección aguda.

Prueba Monospot:

La prueba rápida más usada. Alta especificidad.



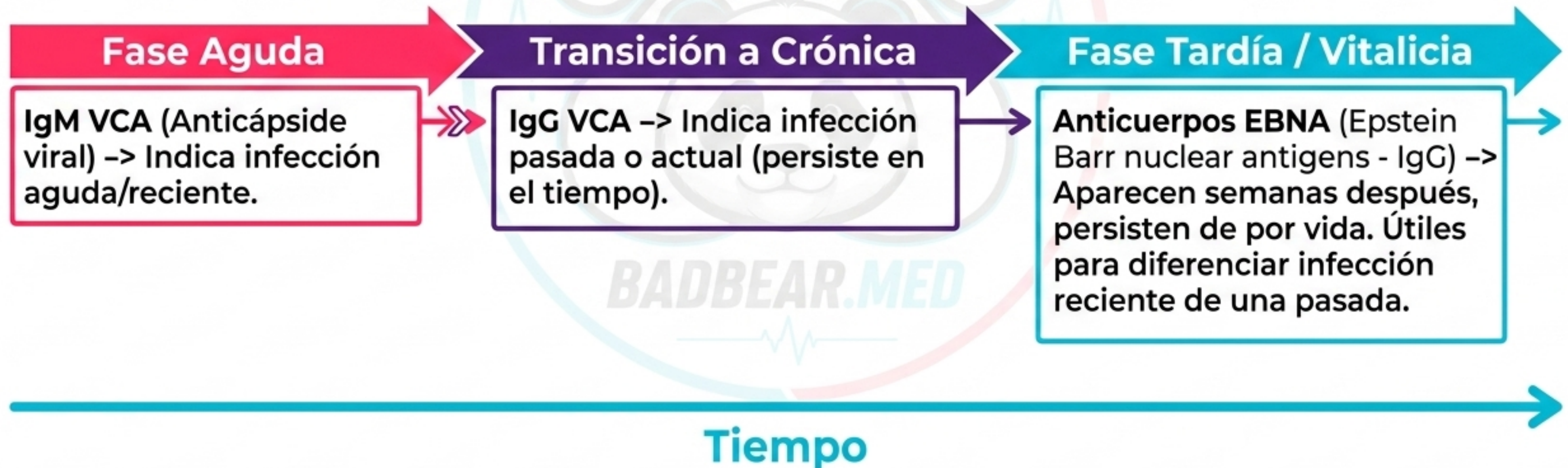
Alerta Clínica:

El Monospot puede dar falsos negativos en la primera semana de síntomas (sensibilidad baja al inicio). Menos confiable en niños pequeños.

Nota: NO es útil aislar el virus, ya que el 95% de los adultos son portadores asintomáticos.

Matriz Diagnóstica: Serología Específica VEB

Uso indicado cuando Monospot es **negativo** pero la **sospecha clínica persiste**, o en **pacientes pediátricos**.



Diagnóstico Diferencial de Linfadenopatía

Infecciosas

Brucelosis, enfermedad por arañazo de gato, CMV, infección primaria por VIH, linfogranuloma venéreo, faringitis, rubéola, tuberculosis, sífilis, hepatitis viral.

Autoinmunes

Lupus, artritis reumatoide, dermatomiositis, síndrome de Sjögren.

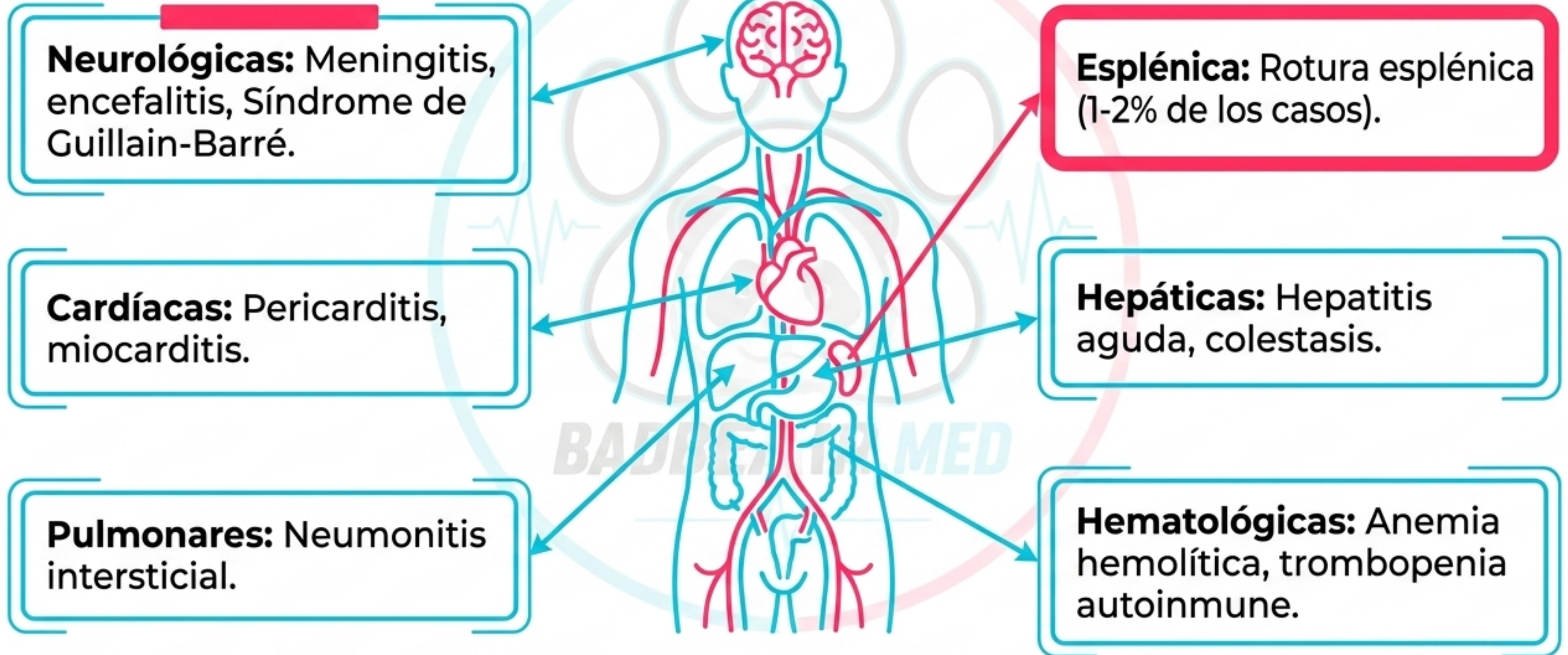
Malignas

Linfomas, leucemias, neoplasias de piel, sarcoma de Kaposi, metástasis.

Misceláneas / Iatrogénicas

Enfermedad de Kawasaki, sarcoidosis, enfermedad del suero, reacciones a medicamentos.

Complicaciones Sistémicas



Manejo y Tratamiento Clínico

La enfermedad es **Autolimitada**.
La base es la terapia de soporte.

Indicaciones Principales



Reposo Absoluto: Crucial para prevenir la complicación más grave (rotura esplénica).



Manejo Sintomático: Uso de acetaminofén para fiebre y dolor.

Contraindicaciones



Antibióticos:
Totalmente contraindicados.
(El uso erróneo de amoxicilina/ampicilina en pacientes con VEB típicamente causa un rash maculopapular severo).

Reto Clínico BADBEAR.MED (Caso 1)

El diagnóstico clínico de Mononucleosis infecciosa por virus Epstein-Barr incluye fiebre y:

- ✓ a) Faringitis, adenomegalia
- b) Artralgias
- c) Faringitis, visceromegalia
- d) Artralgias, visceromegalia
- e) Adenomegalia, visceromegalia

Recuerda la Tríada Clásica:
Fiebre + Faringoamigdalitis
+ Linfadenopatía.

Reto Clínico BADBEAR.MED (Caso 2)

Un niño de 4 años presenta fiebre, faringoamigdalitis con exudados, hepatoesplenomegalia y adenopatías cervicales, inguinales y axilares. Los análisis muestran una leucocitosis, con linfocitosis y

20% de linfocitos atípicos.

¿Cuál es el germen responsable?

- a) Citomegalovirus
- b) Streptococo beta-hemolítico
- c) Virus de la rubeola
- d) Virus de Epstein Barr**
- e) VIH

Proyecto BADBEAR.MED: Reglas de Oro de la Mononucleosis

1. La Tríada

Fiebre abrupta + Faringitis exudativa + Adenopatía = Sospecha inminente.

2. La Célula

Buscar linfocitosis con >10% de Células de Downey (Linfocitos atípicos CD8+).

3. El Manejo

Soporte, hidratación y reposo absoluto preventivo contra rotura esplénica. ¡Cero antibióticos!

Únete al proyecto médico. Síguenos en todas nuestras redes sociales para más masterclasses:
BADBEAR.MED | Facebook • Instagram • YouTube • Rutube • OnlyFans • Telegram • TikTok